FACULDADE LUCIANO FEIJÓ
CURSO DE PSICOLOGIA
PSICOLOGIA JURÍDICA
PROFESSORA: FRANCISCA ALANA ARAÚJO ARAGÃO

VITOR EDVAR SILVEIRA

QUEM TEM O DIREITO DE EXISTIR ENTRE NÓS? UMA ANÁLISE FOUCAULTIANA SOBRE MEDIDA DE SEGURANÇA, PERICULOSIDADE E INSTITUCIONALIZAÇÃO EM A CASA DOS MORTOS

SOBRAL-CE
2026

INTRODUÇÃO

Quando se analisa a história do Brasil e seu processo perante a ideia silenciosa de seletividade e punição dos corpos, pode ser vista uma longa caminhada de movimentações do poder que criaram, segundo Foucault, uma rede capilar de poder nas instituições. Essa rede de poder passa por diferentes instituições e formas de saber, tendo como uma de suas articulações a política, o direito e a psiquiatria, com seu saber médico. Nesse processo, a loucura também passa a ser atravessada por essas relações de poder, deixando de ser somente uma condição atribuída ao sujeito e passando a ser relacionada àquilo que é considerado normal ou anormal dentro da sociedade (PEGDEN; FERREIRA, 2021). O louco durante muito tempo foi visto como um ser além do mundo material, colocado em um lugar muitas vezes próximo de um ser divino, pois, segundo essa percepção, via aquilo que normalmente não se vê e muitas vezes não conseguia se adequar socialmente, o que posteriormente se tornou um problema. Porém, essa relação com a loucura foi sendo modificada conforme novas formas de poder e de saber passaram a organizar a sociedade. Na Idade Média, com o poder concentrado nas mãos do cristianismo, inicia-se uma jornada de "exorcismo" dos loucos, associando determinados comportamentos à presença de demônios e à necessidade de salvar suas almas. Dessa maneira, aquilo que antes poderia ser compreendido como uma diferença passa a ser também algo que deveria ser corrigido e afastado (FOUCAULT, 1978). Mesmo com os avanços culturais e sociais e com a transformação das instituições de poder, essa noção de salvação e seleção dos corpos não desapareceu, mas passou por transformações silenciosas que, ao lado da ciência, contribuíram para a formação da ideologia manicomial que está inserida na concepção do coletivo atual. Segundo Pegden e Ferreira (2021), a partir de Foucault, esse processo pode ser compreendido dentro de uma forma de exercício de poder sobre a vida, que não se limita mais ao domínio da terra, mas passa também pelo controle dos corpos, dos modos de produção e da distribuição do tempo. Assim, o poder passa a operar de maneiras menos visíveis, produzindo formas de organização e controle dos indivíduos (PEGDEN; FERREIRA, 2021). Com isso, a psiquiatria passa a ocupar um lugar importante dentro dessa relação entre saber e poder, pois ao produzir conhecimentos sobre a loucura também passa a estabelecer formas de compreender, classificar e intervir sobre esses sujeitos. A partir dessa relação, aquilo que antes era compreendido principalmente como uma questão moral, religiosa ou social passa a ser também atravessado pelo saber médico, criando novas formas de definir aquilo que seria considerado normal ou anormal. Como apontam Pegden e Ferreira (2021), o dispositivo psiquiátrico participa da produção de verdades sobre o indivíduo e da construção da própria ideia de normalidade, tendo a loucura como uma de suas condições de existência. Nesse processo, a questão deixa de estar somente relacionada à existência da loucura e passa a envolver também o lugar que determinados sujeitos podem ocupar dentro da sociedade. A classificação de um indivíduo como louco, doente ou perigoso não produz apenas uma descrição sobre ele, mas pode determinar as formas pelas quais seu corpo será tratado, vigiado e afastado. É nesse sentido que a lógica manicomial pode ser compreendida não somente como uma forma de tratamento, mas como parte de uma organização social que estabelece limites entre aqueles que podem permanecer no convívio social e aqueles que precisam ser retirados dele. A partir dessa relação entre psiquiatria, poder e controle dos corpos, torna-se necessário questionar

quem define esses limites e quais são as consequências produzidas quando determinadas vidas passam a ser compreendidas principalmente a partir de sua inadequação àquilo que é considerado normal.

DESENVOLVIMENTO

Para compreender como a psiquiatria passa a ocupar esse espaço de poder, é necessário observar que, para Foucault, o poder não funciona somente por meio da lei ou de uma autoridade que determina diretamente aquilo que deve ser feito. Segundo Pegden e Ferreira (2021), Foucault buscava compreender como se constituíram, na modernidade, formas de dominação e apropriação sobre a vida que, mesmo estando além do discurso do Direito, conseguiram se afirmar como discursos de verdade. Com isso, o poder passa também pelo conhecimento e pelas instituições que possuem autoridade para dizer aquilo que é normal, anormal, saudável ou perigoso. Nesse processo, a psiquiatria passa a ocupar um espaço importante, pois seu saber permite classificar determinados indivíduos não somente pelo que fizeram, mas também por aquilo que são e pelo risco que apresentam socialmente. Essa possibilidade foi construída a partir de uma série de relações políticas, processos judiciários, discriminações morais e percepções sociais que produziram as noções de Homem e de loucura. Pegden e Ferreira (2021), ao apresentarem a análise de Foucault, mostram que a doença mental teria surgido justamente desse encontro entre o escândalo moral da loucura, a discriminação social produzida pelo internamento e a consciência jurídica sobre a incapacidade do sujeito. Com isso, a loucura deixa de ser somente uma condição daquele indivíduo e passa também a ser compreendida a partir daquilo que ele poderia representar dentro da sociedade e do Direito. Nesse processo, a psiquiatria começa a se aproximar do Judiciário. A presença da loucura nos tribunais cria um problema para o sistema penal, pois alguns crimes não conseguem ser explicados somente pela relação entre vontade, responsabilidade e punição. Segundo Pegden e Ferreira (2021), a psiquiatria passa então a procurar uma verdade sobre aquele criminoso, tentando compreender aquilo que estaria por trás de sua conduta. O exame psiquiátrico muda a percepção sobre o crime, pois a atenção deixa de estar somente no fato cometido e passa também para a subjetividade do criminoso. Com isso, ao lado da lei, a norma passa a funcionar como um critério para analisar, classificar e compreender aquele indivíduo. Essa mudança ajuda a compreender a diferença entre o indivíduo imputável e o inimputável. No direito penal brasileiro, é considerado inimputável aquele que, em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesses casos, não ocorre a aplicação da pena da mesma forma que ocorre com o indivíduo considerado imputável, podendo ser aplicada a medida de segurança. O Código Penal estabelece como medidas de segurança a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou o tratamento ambulatorial. A diferença, portanto, não está somente no nome dado à resposta jurídica, mas na maneira como esse indivíduo passa a ser compreendido. A medida de segurança está relacionada à condição psíquica e à ideia de tratamento, mas também está ligada à periculosidade. O Código Penal estabelece que a medida de segurança permanece enquanto não for constatada a cessação da periculosidade por perícia médica. A partir disso, a questão deixa de estar

somente no crime cometido e passa também para aquilo que aquele indivíduo pode representar futuramente. A periculosidade desloca então a questão para uma possibilidade futura. Não se trata somente de perguntar o que aquele sujeito fez, mas também aquilo que ele pode vir a fazer. Segundo Pegden e Ferreira (2021), essa transformação está relacionada à ampliação da função da psiquiatria, que passa da patologização da loucura para uma atuação vinculada à ideia de defesa da sociedade. O exame psiquiátrico permite justamente essa mudança, pois torna possível relacionar a conduta do indivíduo a uma determinada verdade sobre sua subjetividade e seu possível risco. Essa lógica também aparece na teoria da degenerescência. Segundo Pegden e Ferreira (2021), a psiquiatria do século XIX passou a relacionar instinto e hereditariedade, fazendo com que determinadas anomalias fossem compreendidas como desvios em relação à própria espécie. Com isso, o perigo deixava de estar somente naquele indivíduo e poderia ser projetado para além dele, sendo apresentado como um risco para a sociedade. A psiquiatria passa, assim, a penetrar no tecido social como instrumento de controle dos indivíduos e da população. É nesse momento que essa discussão se aproxima do biopoder. Para Foucault, conforme apresentado por Pegden e Ferreira (2021), quando a vida passa a ser objeto de intervenção e gerenciamento do poder, a psiquiatria se insere nesse ponto de encontro entre poder e vida. O indivíduo considerado perigoso passa a ser relacionado a um risco que precisa ser administrado. Com isso, a psiquiatria, articulada a outras instituições, passa a participar da definição daqueles que são considerados normais, anormais ou perigosos. A partir disso, a lógica manicomial não pode ser compreendida somente como o ato de colocar alguém dentro de uma instituição. Ela está relacionada a um processo maior de classificação, normalização e controle. Quando determinado sujeito passa a ser definido principalmente por sua doença, sua anormalidade ou sua periculosidade, existe o risco de que sua existência social seja reduzida a essas classificações. Nesse sentido, a questão deixa de ser apenas sobre quem deve ser internado e passa a envolver algo maior: quem possui o poder de definir quais vidas podem permanecer entre nós e quais devem ser afastadas em nome da proteção da sociedade?

CONCLUSÃO

A partir do que foi discutido, pode-se analisar que a lógica manicomial não está somente relacionada à existência das instituições psiquiátricas, mas também à forma como determinados sujeitos passam a ser compreendidos a partir daquilo que é considerado normal, anormal ou perigoso. Quando a psiquiatria se aproxima do Judiciário, o indivíduo deixa de ser analisado somente pelo ato que cometeu e passa também a ser observado por aquilo que pode vir a fazer. A ideia de periculosidade, então, passa a ocupar um lugar importante nessa relação. É nesse ponto que A Casa dos Mortos, de Débora Diniz, apresenta uma dimensão concreta dessa discussão. O documentário mostra pessoas submetidas a medidas de segurança e internadas em um hospital de custódia, onde a ideia de tratamento se mistura com a de controle. A pessoa passa a existir dentro daquela instituição e dentro das classificações jurídica e psiquiátrica que foram construídas sobre ela (DINIZ, 2009). Uma das situações que mais demonstra essa contradição é a história do rapaz que tira a própria vida. De acordo com o relato de seus colegas, antes disso, ele já havia apresentado sinais de sofrimento e falado sobre a possibilidade de matar mais uma pessoa naquela noite,

referindo-se também a si mesmo. Mesmo assim, não houve uma observação, ou alguma movimentação, demonstrando o valor que sua vida naquele lugar. O que mais chama atenção é a naturalidade com que esse acontecimento é contado depois, como se a morte naquele lugar já houvesse sido naturalizada, não como algo excepcional mas como o destino de todos ali, que lutam para atrasá-lo. O indivíduo é considerado perigoso para os outros e, por isso, precisa ser afastado, mas quando o perigo passa a ser contra ele mesmo, o cuidado parece não acontecer da mesma forma. O problema então não é sobre o perigo a vida, e sim a vida daqueles que foram selecionados como importantes (DINIZ, 2009). Essa situação faz questionar até que ponto a medida de segurança consegue cumprir aquilo que afirma buscar. Se existe uma ideia de tratamento e proteção, o abandono de uma pessoa que apresenta sinais de sofrimento dentro da própria instituição mostra uma contradição nessa lógica. A classificação daquele indivíduo como perigoso parece ocupar um espaço maior do que a compreensão sobre aquilo que ele está vivendo. A Luta Antimanicomial coloca justamente essa forma de cuidado em questionamento. A Lei nº 10.216 estabelece que a pessoa com transtorno mental deve ser tratada com humanidade e respeito, buscando sua recuperação por meio da inserção na família, no trabalho e na comunidade, sendo a internação indicada quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes (BRASIL, 2001). Assim, o cuidado não deveria significar simplesmente retirar o indivíduo da sociedade, mas criar possibilidades para que ele continue existindo nela. Dessa forma, A Casa dos Mortos permite retomar a questão apresentada neste trabalho: quem possui o poder de definir quais vidas podem permanecer entre nós e quais precisam ser afastadas em nome da proteção da sociedade? O problema não está em ignorar os crimes ou negar a necessidade de segurança, mas em compreender o que acontece quando o sujeito passa a ser visto principalmente pelo crime, pelo diagnóstico ou pela periculosidade. A Luta Antimanicomial coloca em questão justamente essa separação entre aqueles que podem viver em sociedade e aqueles que devem ser afastados, mostrando a necessidade de pensar formas de cuidado que não transformem a institucionalização em destino.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 1940.

BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Brasília, DF: Presidência da República, 2001.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 487, de 15 de fevereiro de 2023. Institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para sua implementação no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança. Brasília, DF: CNJ, 2023.

DINIZ, Débora. A Casa dos Mortos. Brasil, 2009. Documentário.

PEGDEN, Raphael Thomas Ferreira Mendes; FERREIRA, Arthur Arruda Leal. Dos crimes-sem-razão às razões do eugenismo: racismo de Estado e psiquiatria na origem do conceito de Biopolítica em Michel Foucault. Mnemosine, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 5-25, 2021. DOI: 10.12957/mnemosine.2021.62167.